

De studie JAVELIN Renal 101 vergeleek de combinatie avelumab (immuuntherapie) plus axitinib (TKI) met sunitinib (TKI) bij gevorderd niercelcarcinoom als eerstelijnsbehandeling. “Deze studie toonde wel een verbetering in de ziektevrije overleving, maar in de uiteindelijke analyse was er geen winst in algehele overleving”, vertelt Ronald de Wit.

Publicaties geneesmiddelen

Begin oktober 2020 verschenen er in verschillende media berichten dat Zorginstituut Nederland strenger gaat beoordelen voordat nieuwe behandelingen voor vergoeding in het basispakket in aanmerking komen. Ook gaat het Zorginstituut nadrukkelijker kijken welke zorg die al onder de basisverzekering valt daar weer uit moet, omdat die te weinig effectief is. Deze nieuwe werkwijze moet de oplopende zorguitgaven in toom houden.

Omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is dat de combinatie avelumab plus axitinib leidt tot algehele overlevingswinst heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd deze combinatietherapie niet in de basisverzekering op te nemen. De combinatietherapie pembrolizumab en axitinib (zie hierna de studie KEYNOTE 426) toonde naast toename in ziektevrije overleving ook winst in algehele overleving en zit daarom wel in het verzekerde pakket. Patiënten hoeven zich dus geen zorgen te maken dat ze een behandeling mislopen als gevolg van het niet opnemen van avelumab plus axitinib in de basisverzekering.

De KEYNOTE 426 onderzocht pembrolizumab (immuuntherapie) plus axitinib (TKI) versus sunitinib (TKI).

Die studie toonde zowel winst in ziektevrije overleving als in de algehele overleving. Deze studie toonde overlevingswinst bij alle drie de patiëntgroepen.

Ronald de Wit: “Kijken we naar de winst binnen die drie subgroepen dan zien we dat die overduidelijk is bij de groepen met intermediaire en ongunstige prognose. Maar de winst is bij de patiëntengroep met een goede prognose eigenlijk heel beperkt. Dat is de reden dat naar mening van de Nederlandse behandelaars de standaardbehandeling een middel zoals sunitinib of pazopanib blijft bij de patiëntengroep met een goede prognose.”

Afweging

Voor de patiëntengroepen uitgezaaide nierkanker met een intermediaire of ongunstige prognose ontstaat de vraag: kiezen voor de combinatie-immuuntherapie nivolumab en ipilimumab óf pembrolizumab plus axitinib.

“Dat is best een lastige afweging”, zegt Ronald de Wit, want de overlevingswinst is vergelijkbaar.

“Een belangrijk argument in de afweging is de verwachte last van bijwerkingen.”

“De combinatie-immuuntherapie geeft vooral in de eerste maanden meer immunologische bijwerkingen. Zoals een ontsteking aan darmen, schildklier of lever. Maar na die eerste maanden zijn de bijwerkingen